

Parasitosis intestinales

1. Introducción y relevancia clínica

Las **parasitosis intestinales** son un **problema endémico en Chile**, particularmente en zonas rurales, urbanas periféricas y regiones con déficit de saneamiento básico.

Afectan principalmente a **niños en edad preescolar y escolar**, donde provocan **síntomas digestivos, malnutrición, anemia, bajo rendimiento escolar y retraso del crecimiento**.

Aunque su incidencia ha disminuido gracias a mejoras sanitarias, aún se reportan casos frecuentes de **enterobiasis, giardiasis y helmintiasis intestinales**.

El **MINSAL** considera su diagnóstico y tratamiento parte esencial del **Programa Nacional de Control de las Parasitosis Intestinales** y del **Control del Niño Sano**.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

Las parasitosis intestinales se dividen en dos grandes grupos:

Tipo	Agente principal	Transmisión	Sitio principal
Protozoarios	<i>Giardia lamblia</i> , <i>Entamoeba histolytica</i>	Agua/alimentos contaminados	Intestino delgado y grueso
Helmintos (gusanos)	<i>Enterobius vermicularis</i> , <i>Ascaris lumbricoides</i> , <i>Trichuris trichiura</i> , <i>Strongyloides stercoralis</i>	Fecal-oral o cutánea	Intestino delgado o colon

El ciclo vital suele incluir **fase de infección (ingesta de huevos/quistes)**, **maduración intestinal** y, en algunos casos, **migración tisular** (*Ascaris*, *Strongyloides*).

Los mecanismos de daño son:

- Irritación mecánica de mucosa.

- Competencia nutricional.
 - Reacción inflamatoria local o sistémica.
-

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

A.

Enterobiasis (Oxiuros)

Agente: *Enterobius vermicularis* (oxiuros).

Transmisión:

- Fecal-oral; huevos viables en objetos, ropa o manos contaminadas.
- Autoinfección frecuente.

Clínica:

- **Prurito anal nocturno** (niño inquieto, insomnio).
- Irritabilidad, bruxismo, vulvovaginitis o enuresis secundaria.
- Raramente dolor abdominal.

□ En EUNACOM: “Niña con prurito anal nocturno y vulvovaginitis recidivante → sospechar oxiuriasis.”

Diagnóstico:

- Test de Graham (cinta adhesiva perianal) por la mañana → huevos microscópicos.
 - No se observan en deposiciones.
-

B.

Giardiasis

Agente: *Giardia lamblia* (*duodenalis*, *intestinalis*)

Transmisión:

- Ingesta de quistes por agua o alimentos contaminados.
- Frecuente en jardines infantiles.

Clínica:

- Diarrea **crónica o intermitente**, esteatorrea, meteorismo.
- Dolor abdominal, anorexia y pérdida de peso.
- Retraso ponderal y déficit de absorción (grasas, lactosa).

□ “Niño con diarrea crónica, mal olor y pérdida de peso → giardiasis.”

Diagnóstico:

- Examen parasitológico seriado (3 muestras).
 - Test de antígeno fecal o PCR para *Giardia* (alta sensibilidad).
-

C.**Ascariasis**

Agente: *Ascaris lumbricoides*.

Transmisión:

- Ingesta de huevos maduros del suelo contaminado.
- Ciclo con migración pulmonar.

Clínica:

- Fase intestinal: dolor abdominal, distensión, náuseas.
- Fase pulmonar: tos seca, eosinofilia, síndrome de Loeffler (infiltrados migratorios).
- Complicaciones: obstrucción intestinal o coledociana por masas de gusanos.

Diagnóstico:

- Huevos en deposiciones (coproparasitoscópico).
 - Radiografía o ecografía si obstrucción.
-

D.

Tricuriasis

Agente: *Trichuris trichiura*.

Clínica:

- Diarrea mucosanguinolenta.
- Dolor abdominal tipo cólico.
- En infecciones masivas: prolapso rectal.
- Asociada a desnutrición crónica.

Diagnóstico:

- Huevos característicos en deposiciones (“forma de limón con tapones polares”).
-

E.

Strongyloidiasis

Agente: *Strongyloides stercoralis*.

Transmisión cutánea (penetración larvaria).

Clínica:

- Diarrea persistente.
- Lesiones lineales pruriginosas (“larva currens”).
- Riesgo de diseminación grave en inmunodeprimidos (hiperinfección).

Diagnóstico:

- Larvas en heces frescas o aspirado duodenal.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

Método	Utilidad	Observaciones
Coproparasitoscópico seriado (3 muestras)	Detecta huevos o quistes	Método de elección general
Test de Graham	Diagnóstico de oxiuros	Realizar en la mañana antes del baño
Antígenos fecales / PCR	Alta sensibilidad para <i>Giardia</i> o <i>E. histolytica</i>	Útil en diarrea prolongada
Hemograma	Eosinofilia en helmintiasis	No específico

5. Tratamiento (según Guías MINSAL / OPS 2024)

A.

Antiparasitarios específicos

Parasitosis	Fármaco de elección	Dosis / Duración
Enterobiasis	Mebendazol 100 mg VO cada 12 h × 3 días o dosis única de 500 mg	Repetir a las 2 semanas
Giardiasis	Metronidazol 15 mg/kg/día VO cada 8 h × 7 días o Tinidazol 50 mg/kg dosis única	Tratar a contactos del hogar

Ascariasis / Tricuriasis	Mebendazol 100 mg c/12 h × 3 días o Albendazol 400 mg dosis única	Albendazol preferido por adherencia
---------------------------------	---	-------------------------------------

Strongyloidiasis	Ivermectina 200 µg/kg/día × 2 días	Repetir si inmunodeprimido
-------------------------	------------------------------------	----------------------------

☐ Mebendazol y albendazol son de **amplio espectro** y cubren la mayoría de helmintos intestinales.

B.

Medidas generales

- Tratar a **todos los contactos domiciliarios**.
- Lavado de manos riguroso.
- Higiene de uñas y ropa interior.
- Hervir el agua o usar cloro doméstico (2 gotas por litro).
- Educación en higiene fecal y control de plagas.

C.

Reinfestación

Frecuente, por lo que el MINSAL recomienda **desparasitación preventiva cada 6–12 meses** en zonas de riesgo.

6. Complicaciones y pronóstico

Parasitosis

Complicaciones

Pronóstico

Giardiasis	Malabsorción, déficit ponderal, intolerancia a lactosa	Excelente con tratamiento
Ascariasis	Obstrucción intestinal, pancreatitis, colangitis	Buena si se trata precozmente
Tricuriasis	Prolapso rectal, anemia	Benigna salvo infección masiva
Enterobiasis	Vulvovaginitis, insomnio crónico	Muy buena
Strongyloidiasis	Hiperinfección diseminada (inmunodeprimidos)	Grave si no se trata

7. Prevención y control comunitario

A.

Medidas individuales

- Lavado de manos antes de comer y después de ir al baño.
- Lavado cuidadoso de frutas y verduras.
- Uso de calzado (previene helmintos del suelo).
- Evitar fecalismo al aire libre.

B.

Medidas poblacionales

- Educación sanitaria en escuelas.
- Saneamiento básico y agua potable.

- Programas escolares de desparasitación (MINSAL-OPS).
 - Vigilancia epidemiológica.
-

8. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

☐ Perlas:

1. **Prurito anal nocturno:** enterobiasis (oxiuros).
2. **Diarrea crónica y esteatorrea:** giardiasis.
3. **Huevos en deposiciones:** diagnóstico de ascaris/trichuris.
4. **Fiebre y eosinofilia:** fase pulmonar de ascaris.
5. **Tratamiento de elección:** albendazol o mebendazol (amplio espectro).
6. **Desparasitación familiar:** previene reinfección.
7. **Hervir agua y mejorar saneamiento:** clave en prevención.

☐ Errores frecuentes:

- No repetir dosis en oxiuriasis.
 - Omitir tratamiento a contactos domiciliarios.
 - Usar antibióticos en diarrea parasitaria.
 - No investigar *Giardia* en diarrea crónica.
 - Olvidar la prevención escolar y comunitaria.
-

9. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **Parasitosis intestinales** son frecuentes en la infancia chilena.
2. ***Giardia lamblia*** → diarrea crónica y malabsorción.

3. **Enterobius vermicularis** → prurito anal nocturno.
4. **Ascaris / Trichuris** → helmintiasis intestinales con eosinofilia.
5. **Tratamiento base:** albendazol o mebendazol (amplio espectro).
6. **Desparasitar contactos y repetir dosis a las 2 semanas.**
7. **Prevención:** higiene, agua potable y saneamiento básico.